



ПАПЕРОВА КОПІЯ
ЕЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (НСЗУ)

просп. Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073, тел.: (044) 426-67-77, (044) 290-06-91
E-mail: info@nszu.gov.ua, сайт: www.nszu.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 42032422

від _____ 20__ р. № _____

На № _____ від _____ 20__ р.

Закладам охорони здоров'я (за списком)

Національна служба здоров'я України (далі – НСЗУ) висловлює свою повагу та надає роз'яснення щодо правил ведення електронних медичних записів (далі – ЕМЗ) в електронній системі охорони здоров'я (далі – ЕСОЗ) потенційному мертвому донору/мертвому донору.

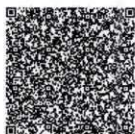
Відповідно до Статті 52 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» моментом незворотної смерті людини є момент смерті її головного мозку або її біологічна смерть.

Порядок припинення активних заходів щодо підтримання життя пацієнта, порядок констатації та діагностичні критерії смерті мозку людини, положення про консилиум лікарів, форма акта про констатацію смерті мозку людини визначено наказом Міністерства охорони здоров'я України «Про деякі питання удосконалення роботи відділень анестезіології та інтенсивної терапії закладів охорони здоров'я» від 09.11.2020 № 2559.

Відповідно до пункту 3 «Порядку припинення активних заходів щодо підтримання життя пацієнта» активні заходи щодо підтримання життєдіяльності пацієнта припиняються у випадку підтвердження незворотної смерті - констатації смерті мозку пацієнта консилиумом лікарів, за винятком випадків, коли померла людина розглядається як потенційний донор.

Відповідно до Статті 1 Розділу I Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині», потенційний донор – померла особа, щодо якої існують медичні передумови (відсутність хвороб або станів, що унеможливають вилучення анатомічних матеріалів людини) для вилучення анатомічних матеріалів, але не отримано трансплант-координатором в установленому цим Законом порядку відомості щодо можливості (згода) вилучення анатомічних матеріалів з її тіла для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів. Відповідно до «Порядку констатації та діагностичні критерії смерті мозку людини» в разі констатації смерті мозку потенційному донору до моменту вилучення органів проводиться **кондиціонування** – сукупність дій медичного характеру, спрямованих на забезпечення підтримання функцій життєво важливих органів та систем потенційного донора.

Зважаючи на вище наведене, в ЕСОЗ розроблено новий тип епізоду «Кондиціонування», в рамках якого можна обліковувати свої дії після смерті пацієнта, на етапі підтримання функцій життєво важливих органів та систем потенційного донора.



СЕД АСКОД - Національна служба здоров'я України
Документ № 6654/6-15-25 від 13.02.2025
Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000007866330044EAD800
Підписувач: Гусак Наталія Борисівна
Дійсний з: 13.09.2024 00:00:00 по 12.09.2026 23:59:59

Передумовою для створення Епізоду МД "Кондиціонування" є створення ЕМЗ "Виписка зі стаціонару" з результатом лікування "Помер".

ЕМЗ для пацієнтів, яким встановлено діагноз смерть мозку та пацієнта визнано потенційним донором, має містити наступну інформацію:

1. *Підстава надання послуги* – вибрати одне з:

- За електронним направленням;
- Самозвернення;
- Доставлений бригадою екстреної медичної допомоги;
- Переведений з іншого ЗОЗ;
- Переведений з іншого відділення;
- Доставлений третіми особами.

Пошук е-направлення в ЕСОЗ виконується за груповим номером направлення.

2. *Епізод*. Тип епізоду «Лікування», де дата початку епізоду зазначається як дата госпіталізації в стаціонар.

3. *ЕМЗ «Взаємодія»*:

- *Клас взаємодії* – «Стаціонарна медична допомога»;
- *Тип взаємодії* – «Виписка пацієнта, який вибув зі стаціонару»;
- *Результат лікування* – «помер(ла)».

4. *Основний діагноз* – зазначити діагноз, який встановлено після обстеження і який є основною причиною виникнення епізоду лікування пацієнта та на який спрямовано основні медичні інтервенції.

5. *Клінічний статус основного діагнозу* – завершений.

6. *Статус достовірності діагнозу* – «Заключний».

7. *Додатковий діагноз* – обов'язково зазначаються:

- **G93.82** Смерть головного мозку;
- **Z00.5** Обстеження потенційного донора органу й тканини, що свідчить про намір заготівлі, навіть якщо органи в подальшому не заготовляють.

Також зазначаються діагнози, що мають відношення до даного клінічного випадку, обов'язково кодувати ускладнення, які виникли під час надання медичної допомоги.

8. *Проведені дії* – опис проведених дій відбувається за НК 026:2021 «Класифікатор медичних інтервенцій», зазначаються коди процедур, які були проведені під час лікування

9. *Закриття епізоду* - епізод має бути закритим, електронне направлення на даний вид лікування погашене. Перед закриттям епізоду лікуючий лікар створює направлення на послугу A33011 «Аналіз; антиген лейкоцитів людини» для визначення HLA-генів методом ПЛР. Дата закриття епізоду дата діагностованої смерті мозку (момент смерті пацієнта) відповідно до «Акту констатації смерті мозку людини».

Правила обліку проведених дій за типом епізоду «Кондиціонування»

Відповідно до пункту 5 розділу I «Складу та основних завдань бригади вилучення анатомічних матеріалів людини», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 11.06.2021 № 1184 «Деякі питання організації посмертного донорства», після констатації смерті мозку продовжується кондиціонування потенційного донора, про що вноситься відповідний запис у формі первинної облікової документації № 003/о «Медична карта стаціонарного хворого», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974.

Записи щодо лікарських засобів використаних під час кондиціонування потенційного донора вносяться до форми первинної облікової документації № 003-4/о «Листок лікарських призначень», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522.

Відповідно до Статті 1 Розділу I Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині», донор-труп – померла особа, щодо якої в установленому цим Законом порядку отримано згоду на вилучення з її тіла анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів.

Відповідно до пункту 7 розділу III «Складу та основних завдань бригади вилучення анатомічних матеріалів людини», вилучення у донора-трупа анатомічних матеріалів для трансплантації документується шляхом заповнення форми № 033/о «Акт про вилучення анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 11 червня 2021 року № 1184 (далі - форма № 033/о).

Форма № 033/о підписується лікарями, які брали участь у вилученні анатомічних матеріалів для трансплантації, а у разі призначення судово-медичної експертизи - також судово-медичним експертом, і долучається до висновку судово-медичного експерта, медичної документації донора-трупа та реципієнта.

Отже, в ЕСОЗ облік дій із забезпечення підтримання функцій життєво важливих органів та систем потенційного донора відбувається таким чином:

1. *Підстава надання послуги* – «ургентний стан».
2. *Епізод* – Лікар створює новий епізод типу «Кондиціонування», де датою початку епізоду зазначається дата діагностованої смерті мозку (момент смерті пацієнта) відповідно до «Акту констатації смерті мозку людини».
3. *ЕМЗ «Взаємодія»*:
 - *Клас взаємодії* – «Стаціонарна медична допомога»;
 - *Тип взаємодії* – «Взаємодія у закладі охорони здоров'я».
4. *Основний діагноз* – зазначається один із діагнозів рубрики **Z52** «Донори органів та тканин». У разі вилучення декількох органів, відповідно до «Акту про вилучення анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації», решта діагнозів рубрики **Z52** вказуються в додатковому діагнозі. Вказувати цей діагноз, навіть якщо органи згодом не вилучаються.
5. *Статус достовірності діагнозу* – «Заклучний».

6. *Додатковий діагноз* – обов'язково зазначаються діагнози рубрики **Z52** «Донори органів та тканин» в разі вилучення декількох органів відповідно до «Акту про вилучення анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації».

Якщо органи (усі) не вилучають для проведення трансплантації, в супутніх діагнозах зазначають код **Z00.5** Обстеження потенційного донора органа й тканини та код **Z53.8** Процедура не проведена з інших причин.

7. *Проведені дії* – опис проведених дій відбувається за НК 026:2021 «Класифікатор медичних інтервенцій». Вказуються коди інтервенцій, які були проведені під час кондиціонування, зокрема:

- **13882-00** Ведення пацієнта при проведенні безперервної ШВЛ, ≤ 24 годин
- **13882-01** Ведення пацієнта при проведенні безперервної ШВЛ, > 24 і < 96 годин.
- **96231-00** Апаратна перфузія при трансплантації органів, якщо апаратна перфузія використовується для заготівлі органів.
- **13839-00** Взяття крові для діагностики (для визначення генотипу HLA).

8. *ЕМЗ «Процедура»* – на вилучення кожного органу створюється окремий ЕМЗ «Процедура».

- **90204-00** Видалення серця донора для пересадки;
- **90204-01** Видалення серця та легені донора для пересадки;
- **38438-03** Видалення легені донора для пересадки;
- **96258-03** Забір печінки для трансплантації, трупний донор;
- **36516-06** Повна нефректомія задля трансплантації, трупний донор.

ЕМЗ «Процедура» необхідно створювати, навіть якщо орган не вилучається, у такому випадку в даному ЕМЗ необхідно зазначати, що процедуру не проведено.

9. *Закриття епізоду*. Після вилучення органів або визнання потенційного донора непридатним до донорства епізод має бути закритим. Дата закриття епізоду – час закінчення вилучення органів відповідно до «Акту про вилучення анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації» або дата встановлення непридатності до донорства потенційного донора.

Голова

Наталія ГУСАК

